

Empirische Sozialforschung (ESF) Glossar

FACHGLOSSAR EMPIRISCHE SOZIALFORSCHUNG (ESF)

Physio-/Ergotherapie | Prüfungsfest

A

Abhängige Variable (AV) — Merkmal/Outcome, das sich durch die unabhängige Variable verändert und gemessen wird. Stellt das Ergebnis dar, das man untersuchen möchte. | *Abgrenzung:* Unterscheidet sich von UV (Ursache) und Kovariablen (Störfaktoren). | *Beispiel Physiotherapie (PT):* Bei der Frage „Reduziert PT Rückenschmerz?“ ist Schmerzintensität die AV.

Assessments (Messinstrumente) — Standardisierte Verfahren zur objektiven Messung abstrakter Konstrukte (Lebensqualität, motorische Kontrolle) oder konkreter Größen (Gewicht, ROM). Müssen Gütekriterien erfüllen. | *Abgrenzung:* Unterscheidet sich von alltäglicher Beobachtung durch Standardisierung und Validität. | *Beispiel PT:* Der „Timed Up and Go“-Test für Sturzrisiko bei älteren Menschen.

Auswertungsphase — Phase des empirischen Forschungsprozesses, in der erhobene Daten analysiert und interpretiert werden (deskriptive/induktive Statistik). | *Abgrenzung:* Folgt der Untersuchungsphase; unterscheidet sich von Datenerhebung. | *Beispiel:* Berechnung von Mittelwerten, p-Werten und Signifikanztests.

B

Beobachtungsstudie — Empirische Studie ohne Intervention; Forscher:in beobachtet natürlich vorkommende Unterschiede (z. B. Fall-Kontroll-, Kohorten-Studie). | *Abgrenzung:* Unterscheidet sich von Interventionsstudien (Randomisierte kontrollierte Studie (RCT)) durch fehlende Manipulation. | *Beispiel PT:* Vergleich von Schmerzverläufen bei Patient:innen mit/ohne Depression (retrospektive Kohorte).

Bias (systematischer Fehler) — Vermeidbarer, nicht-zufälliger Fehler, der Studienergebnisse systematisch verfälscht (z. B. Selection Bias, Detection Bias). | *Abgrenzung:* Unterscheidet sich von Zufallsfehlern durch Systematik und Vorhersehbarkeit. | *Beispiel:* Therapeut:in kennt Gruppenzugehörigkeit und behandelt Interventionsgruppe intensiver.

Binäre Variable — Qualitative Variable mit nur 2 Kategorien/Ausprägungen. | *Abgrenzung:* Spezialfall nominaler Variablen; unterscheidet sich von mehrkategorialen. | *Beispiel:* Geschlecht (m/w), Gruppenzugehörigkeit (Intervention ja/nein).

D

Datenreduktion — Zusammenfassung großer Datenmengen mittels statistischer Verfahren auf wesentliche Merkmale (Mittelwerte, Häufigkeiten). | *Abgrenzung:* Qualitative Forschung reduziert erst bei Auswertung; quantitativ bereits bei Erhebung. | *Beispiel:* 50 Schmerzwerte -> Mittelwert (MW) $5,2 \pm 1,8$ (SD).

Deduktion — Erkenntnisprozess vom Allgemeinen (Theorie/Hypothese) zum Einzelfall. Theorie wird in ausgewählter Stichprobe überprüft. | *Abgrenzung:* Gegenpol zur Induktion; typisch für quantitatives Paradigma. | *Beispiel PT:* „PT hilft bei LBP“ (Theorie) -> Test mit 30 Patient:innen -> Bestätigung/Widerlegung.

Delphi-Befragung — Qualitative Methode mit mehreren Befragungsrunden Expert:innen zur Konsensfindung; iterativer Prozess. | *Abgrenzung:* Unterscheidet sich von einfachen Interviews durch Mehrfach-Abfragen. | *Beispiel:* Konsens über minimale klinisch relevante Unterschiede in PT-Outcomes erzielen.

Deskriptive Statistik — Beschreibung und Zusammenfassung von Rohdaten durch Lagemaße (Mittelwert, Median), Streuungsmaße (SD, Range) und Häufigkeiten. | *Abgrenzung:* Unterscheidet sich von induktiver Statistik (keine Generalisierung auf Population). | *Beispiel:* „n=50, MW Alter=62 Jahre, SD=8,5; 60 % weiblich.“

Diskret — Variable mit nur bestimmten, ganzzahligen Werten (nicht kontinuierlich); abzählbar. | *Abgrenzung:* Unterscheidet sich von stetigen Variablen. | *Beispiel:* Anzahl der Therapiesitzungen (1, 2, 3...), nicht 2,5.

E

Emergente Designs — Flexible Forschungspläne, die sich während des Prozesses anpassen; typisch für qualitative Forschung. | *Abgrenzung:* Unterscheidet sich von linearen, standardisierten Designs der Quantita. | *Beispiel:* Interview-Leitfaden wird nach den ersten Interviews angepasst.

Empirische Forschung — Systematische Erfassung und Deutung sozialer/gesundheitsbezogener Tatbestände durch methodische Datenerhebung und Analyse. | *Abgrenzung:* Beruht auf Beobachtung/Erfahrung, nicht nur Theorie. | *Beispiel:* RCT zur Wirksamkeit von Gleichgewichtstraining bei Sturzprävention.

Empirismus — Erkenntnistheorie, bei der Erfahrung und Beobachtung der Außenwelt Basis aller Ideen sind (Induktion). Problem: Naturkausalität nicht beweisbar. | *Abgrenzung:* Gegenpol zu Rationalismus; Grundlage qualitativer Forschung. | *Beispiel:* Viele Beobachtungen -> allgemeine Regel.

F

Falsifikation — Widerlegung einer Hypothese oder Theorie durch empirische Untersuchung (nach K. Popper). Theorien können nicht verifiziert, nur falsifiziert werden. | *Abgrenzung:* Unterscheidet sich von Verifikation (unmöglich). | *Beispiel:* Studie zeigt: PT hilft NICHT bei allen LBP -> Hypothese nicht falsifiziert, aber nicht verifiziert.

Fall-Kontroll-Studie — Retrospektive Beobachtungsstudie; Vergleich von Personen mit (Fälle) und ohne (Kontrollen) Erkrankung bezüglich Risikofaktoren. | *Abgrenzung:* Unterscheidet sich von Kohortenstudie (prospektiv); kleinere Stichprobe möglich. | *Beispiel PT:* Personen mit/ohne Nackenschmerz -> Vergleich früherer Haltung, Stress.

Falsifizierbarkeit — Möglichkeit, eine Hypothese durch empirische Daten zu widerlegen; notwendiges Kriterium wissenschaftlicher Hypothesen. | *Abgrenzung:* Metaphysische Aussagen sind nicht falsifizierbar. | *Beispiel:* „PT hilft bei LBP“ ist falsifizierbar; „Im Himmel ist es friedlicher“ nicht.

Felduntersuchung — Datenerhebung in natürlicher Umgebung der Proband:innen (nicht Labor). | *Abgrenzung:* Unterscheidet sich von Laboruntersuchungen durch weniger Kontrolle, aber höhere ökologische Validität. | *Beispiel PT:* Assessment von Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) in der Wohnung nach Schlaganfall.

Fokus-Gruppe — Qualitative Methode: Diskussion eines Themas in homogener Gruppe (gemeinsame Hintergründe); gegenseitige Stimulation. | *Abgrenzung:* Unterscheidet sich von Einzelinterviews durch Gruppendynamik. | *Beispiel Ergotherapie (ET):* 6–8 Ergotherapeut:innen diskutieren Akademisierung der Berufe.

Forschungsdesign — Plan zur Beantwortung der Forschungsfrage; legt Studientyp, Stichprobe, Datenerhebung, Analyse fest. Nicht nachträglich änderbar. | *Abgrenzung:* Übergeordneter Begriff für quantitativ/qualitativ/mixed methods. | *Beispiel:* „Randomisierte kontrollierte Studie mit Prä-Post-Design, n=60.“

Forschungsfrage (FF) — Präzise, empirisch überprüfbare Frage zur Beantwortung durch Forschung. Im PICO-Format: Population, Intervention/Phänomen, Comparison, Outcome. | *Abgrenzung:* Unterscheidet sich von Hypothesen (spezifischer, testbar). | *Beispiel:* „Reduziert Gleichgewichtstraining bei älteren Menschen (P) Sturzrate (O) im Vgl. zu Standardtherapie (C)?“

G

Grundgesamtheit (Population) — Gesamtheit aller Individuen/Objekte, über die eine Aussage getroffen werden soll (z. B. „alle Patienten mit LBP in Deutschland“). | *Abgrenzung:* Unterscheidet sich von Stichprobe (Teilmenge). | *Beispiel PT:* Grundgesamtheit: alle Patient:innen mit akutem LBP; SP: 50 aus einer Klinik.

Grounded Theory (GT) — Qualitative Methode zur explorativen Theorieentwicklung aus Datenmaterial ohne Vorwissen; iterativer Prozess (theoretisches Sampling). | *Abgrenzung:* Unterscheidet sich von Phänomenologie (nicht subjektive Erfahrung, sondern soziale Prozesse). | *Beispiel PT:* Interviews mit Patient:innen -> Theorie über Bewältigung chronischer Schmerzen entwickeln.

Gütekriterien — Qualitätsstandards für Forschung. *Quantitativ:* Objektivität, Reliabilität, Validität. *Qualitativ:* Regelgeleitetheit, Verfahrensdokumentation, Nähe, Inter-coder-Reliabilität, kommunikative/argumentative Validierung. | *Abgrenzung:* Unterscheiden sich zwischen Paradigmen. | *Beispiel:* RCT muss blind, randomisiert sein; qualitative Studie muss Vorverständnis reflektieren.

H

Hypothese — Provisorische, widerspruchsfreie Antwort auf wissenschaftliches Problem in Konditionalsatz-Form („Wenn-dann“). Muss empirisch überprüfbar, allgemeingültig, falsifizierbar sein. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von Vermutung (populär) durch Wissenschaftlichkeit. | *Beispiel*: „Wenn PT mit Gleichgewichtstraining durchgeführt wird, dann reduziert sich Sturzrate bei älteren Menschen.“

Hypothesengenerierung — Entwicklung neuer Hypothesen aus Forschungsergebnissen (induktiv, qualitativ). | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von Hypothesentestung (deduktiv, quantitativ). | *Beispiel*: Qualitative Studie zu Nackenschmerz -> neue Hypothese über psychosomatische Faktoren.

I

Induktion — Erkenntnisprozess vom Einzelfall zum Allgemeinen; von Beobachtungen auf Gesetzmäßigkeiten schließen. Logisches Problem: Naturkausalität nicht beweisbar. | *Abgrenzung*: Gegenpol zu Deduktion; typisch für qualitatives Paradigma. | *Beispiel*: 50 Patient:innen bessern sich mit PT -> „PT hilft bei LBP allgemein.“

Induktive Statistik — Wahrscheinlichkeitsaussagen über Grundgesamtheit basierend auf Stichprobendaten (Signifikanztests, Konfidenzintervalle, p-Wert (Signifikanzwahrscheinlichkeit)). | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von deskriptiver Statistik (keine Generalisierung). | *Beispiel*: $p < 0,05$ -> Unterschied in SP wahrscheinlich auch in GG vorhanden.

Intercoder-Reliabilität — Übereinstimmung zwischen mehreren unabhängigen Kodierenden bei qualitativer Auswertung; Maß für Zuverlässigkeit. | *Abgrenzung*: Qualitativ-spezifisches Gütekriterium; bei Quanti: Test-Retest-Reliabilität. | *Beispiel*: Zwei Analytiker:innen codieren Interviews unabhängig; Übereinstimmung >80 %.

Intervallskala — Metrische Skala mit gleichmäßigen Abständen, aber ohne absoluten Nullpunkt. Unterschiede sind interpretierbar, Verhältnisse nicht. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von Verhältnisskala (absoluter Nullpunkt). | *Beispiel*: Temperatur in Celsius (0°C = willkürlich, nicht „keine Temperatur“).

Iterativer Prozess — Zirkuläre, wiederholte Prozessschritte mit Rückkopplung; typisch für qualitative Forschung. Datenerhebung und Analyse erfolgen parallel. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von linearem Prozess (quantitativ: Plan -> Erhebung -> Analyse). | *Beispiel*: Interview 1 -> Auswertung -> Leitfaden anpassen -> Interview 2 -> ...

K

Kausalität — Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen Variablen. Idealfall empirischer Forschung, aber oft schwer nachzuweisen. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von Korrelation (Zusammenhang ohne Richtung). | *Beispiel PT*: Depression (Ursache?) -> LBP (Wirkung?) oder umgekehrt?

Klinische Studie — Empirische Studie mit Intervention an Menschen zur Prüfung von Therapiewirksamkeit (nicht-kontrolliert oder kontrolliert/RCT). | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von epidemiologischen Studien (keine Intervention). | *Beispiel*: RCT: PT mit/ohne Gleichgewichtstraining

bei älteren Menschen.

Kohorte — Gruppe von Personen mit gemeinsamen Merkmalen (z. B. Geburtsjahr), die über Zeit verfolgt wird. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von Querschnittsstichprobe (Zeitpunkt). | *Beispiel*: Alle Patient:innen mit akutem LBP 2024 -> 6 Monate Follow-up.

Kohortenstudie — Prospektive oder retrospektive Längsschnittstudie; Vergleich von exponierten vs. nicht-exponierten Personen bezüglich Outcome. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von Fall-Kontroll-Studie (prospektiv statt retrospektiv). | *Beispiel ET*: Patient:innen mit/ohne Handhygiene-Training -> Infektionsrate über 6 Monate.

Konditionalsatz — Grammatikalische Form „Wenn-dann“ oder „Je-desto“ für Hypothesenformulierung. Notwendig für wissenschaftliche Hypothesen. | *Abgrenzung*: Fragen oder Aussagen ohne diese Form sind keine wissenschaftlichen Hypothesen. | *Beispiel*: „Wenn PT mit Ausdauertraining durchgeführt wird, dann verbessert sich kardiopulmonale Fitness.“

Konfidenzintervall — Wertebereich, in dem der wahre Populationsparameter mit bestimmter Wahrscheinlichkeit (meist 95 %) liegt. Alternative zu p-Wert. | *Abgrenzung*: Gibt Präzision der Schätzung an, nicht nur „signifikant ja/nein“. | *Beispiel*: Schmerzreduktion $3,2 \pm 2,1$ Punkte; 95%-KI [0,8; 5,6].

Kontrollgruppe — Vergleichsgruppe in Interventionsstudie, die keine oder alternative Intervention erhält (z. B. Placebo, TAU). | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von Interventionsgruppe durch Exposition. | *Beispiel*: PT-Gruppe vs. Wartelisten-Kontrollgruppe (TAU).

Kritischer Rationalismus — Erkenntnistheorie (K. Popper): Theorien nicht verifizierbar, nur falsifizierbar; Metaphysik vs. naturwissenschaftliche Sätze. | *Abgrenzung*: Mittelpunkt zwischen Rationalismus und Empirismus. | *Beispiel*: „Alle Schwäne sind weiß“ falsifiziert durch einen schwarzen Schwan.

Qualitative Forschung — Nicht-standardisierte Datenerhebung (Interviews, Beobachtung) und interpretative Auswertung; induktiv, theoriegenerierend. Fokus: Sinn, Verstehen, Subjektivität. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von Quanti durch Offenheit, weniger Standardisierung, kleine Stichproben. | *Beispiel*: Leitfaden-Interviews mit 12 PT:innen über Akademisierung.

Qualitatives Paradigma — Interpretatives Paradigma: Suche nach subjektiver Wahrheit; Verstehen von Situationsdefinitionen und Handlungen als Sinnkonstruktionen. Nicht-standardisierte Datenreduktion erst bei Auswertung. | *Abgrenzung*: Gegenpol zum quantitativen (normativen) Paradigma. | *Beispiel*: Phänomenologie, Grounded Theory, qualitative Inhaltsanalyse.

L

Längsschnittstudie — Empirische Studie mit mehreren Messzeitpunkten (prospektiv/retrospektiv); misst Veränderungen über Zeit. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von Querschnittsstudie (ein Zeitpunkt). | *Beispiel PT*: Schmerzintensität bei LBP: Baseline -> 2 Wo. -> 6 Wo. -> 3 Mon. nach PT.

Leitfadengestütztes Interview — Qualitative Methode: Semi-strukturiertes Interview mit offenen Fragen, Nachfragen; Leitfaden flexible Struktur. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von narrativen (ganz

offen) und standardisierten (sehr strukturiert). | *Beispiel*: Interview zu Erfahrungen mit PT nach Schlaganfall; Fragen vorbereitet, aber flexibel.

M

Maximum-Variation Sampling — Qualitative Samplingsstrategie: bewusste Auswahl kontrastierender Fälle zur Abdeckung des Merkmalsspektrums. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von Purposive oder Convenience Sampling. | *Beispiel*: Auswahl von PT-Patient:innen mit unterschiedlich schweren LBP-Graden.

Median — Zentralwert der sortierten Daten; 50 % darunter, 50 % darüber. Robust gegen Ausreißer. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich vom Mittelwert (arithmetisches Mittel) bei schiefen Verteilungen. | *Beispiel*: Schmerzwerte [1, 3, 5, 7, 9] -> Median = 5.

Messinstrument — Standardisiertes Verfahren zur Quantifizierung von Konstrukten oder Größen. Muss Validität, Reliabilität, Objektivität erfüllen. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von alltäglicher Messung durch Standardisierung. | *Beispiel*: OSWESTRY Disability Index (ODI) für Behinderung bei LBP.

Meta-Analyse — Statistische Zusammenfassung mehrerer Studien zum gleichen Thema; kombiniert Ergebnisse, erhöht Fallzahlen. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von narrativen Reviews durch quantitatives Verfahren. | *Beispiel*: 15 RCTs zu PT-Wirksamkeit bei Nackenschmerz -> gepoolte Effektgröße berechnen.

Methodologie — Lehre der Methoden; theoretischer Rahmen für Forschungsvorgehen. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von Methode (konkrete Technik). | *Beispiel*: Phänomenologie als Methodologie; qualitatives Interview als Methode.

Methode — Konkrete Technik der Datenerhebung oder -analyse (z. B. Interview, Fragebogen, SPSS-Test). | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von Methodologie (theoretischer Rahmen). | *Beispiel*: „Semi-strukturiertes Interview“ als Methode.

Mittelwert (MW) — Arithmetisches Mittel; $\text{Summe aller Werte} \div \text{Fallzahl}$. Empfindlich gegen Ausreißer. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich vom Median (bei schiefen Verteilungen). | *Beispiel*: Schmerzwerte [2, 4, 6] -> MW = 4.

Mixed Methods — Kombination von quantitativen und qualitativen Methoden in einer Studie. Alternative zum „Paradigmenkrieg“. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von reinen Quanti oder Quali. | *Beispiel*: RCT (Quanti) + Leitfaden-Interviews mit erfolgreichen und nicht-erfolgreichen Teilnehmer:innen (Quali).

N

Narratives Interview — Qualitative Methode: Offenes Interview mit minimaler Struktur; Erzählaufförderung. Sehr explorativer Ansatz. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von Leitfaden-Interviews (weniger Struktur). | *Beispiel*: „Erzählen Sie von Ihrer Erfahrung mit der Therapie nach Ihrem Schlaganfall.“

Nominalskaliert — Kategoriale Skala mit >2 Kategorien, ohne Rangordnung. Häufigkeiten/Modus sinnvoll. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von ordinaler (Rangordnung). | *Beispiel*: Haarfarbe (braun, blond, schwarz, rot), Religionszugehörigkeit.

Nonreaktive Verfahren — Qualitative Methode: Beobachtung ohne Kontakt zwischen Forscher:in und Untersuchungsobjekt (z. B. physische Spuren, Dokumente). | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von reaktiven Methoden (Interview, Beobachtung mit Kontakt). | *Beispiel*: Analyse von Markierungen/Verschleiß in Therapieräumen.

O

Objektivität — Gütekriterium: Unabhängigkeit von Forscher:in; Ergebnisse sollten reproduzierbar sein. *Durchführungs-, Auswertungs-, Interpretationsobjektivität*. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von Reliabilität (Genauigkeit). | *Beispiel*: Standardisierter Schmerzfragebogen unabhängig vom Therapeut:in mit gleichem Ergebnis.

Offenheit (qualitative Forschung) — Prinzip: Forscher:in offen gegenüber neuen Informationen, Phänomenen; keine vorschnelle Kategorisierung. Vorverständnis wird reflektiert. | *Abgrenzung*: Quantitativer Forschung liegt Theorie zugrunde. | *Beispiel*: Interview-Leitfaden vorbereitet, aber flexibel für unerwartete Themen.

Operationalisierung — Konkrete Definition, wie abstrakte Konstrukte gemessen werden. Umwandlung in beobachtbare, messbare Indikatoren. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von theoretischer Definition. | *Beispiel*: Konstrukt „Handfunktion“ -> gemessen mit „Purdue Pegboard Test“ oder „NHPT“.

Ordinalskaliert — Kategoriale Skala mit Rangordnung, aber keine gleichmäßigen Abstände. Median, Modus sinnvoll. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von Nominalskaliert (keine Ordnung) und Intervallskaliert (gleichmäßige Abstände). | *Beispiel*: Schulnoten (1–6), Platzierung im Wettbewerb, Schwierigkeitsgrad.

Outcome — Ergebnis, Endpunkt einer Maßnahme. *Primärer Outcome*: Hauptziel der Studie. *Sekundärer Outcome*: weitere Effekte. | *Abgrenzung*: Entspricht abhängiger Variable (AV). | *Beispiel* PT: Primär: Schmerzreduktion; Sekundär: Verbesserung ADL, Zufriedenheit.

P

Paradigma — Übergeordnete Erkenntnistheorie. *Quantitativ*: normativ, deduktiv, theorietestend. *Qualitativ*: interpretativ, induktiv, theoriegenerierend. | *Abgrenzung*: Unterschiede in Ziele, Methoden, Verallgemeinerung. | *Beispiel*: RCT (quantitativ) vs. Phänomenologie (qualitativ) = unterschiedliche Paradigmen.

Phänomenologischer Ansatz — Qualitative Methode: Erforscht subjektive Erfahrungen und Wahrnehmungen von Individuen; wie Menschen die Welt deuten. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von Grounded Theory (nicht soziale Prozesse im Fokus). | *Beispiel*: Interviews mit MS-Patient:innen über alltägliche Herausforderungen und Bewältigung.

PICO — Schema zur Formulierung der Forschungsfrage: **P**opulation, **I**ntervention/Phänomen, **C**omparison, **O**utcome. | *Abgrenzung*: Strukturiert FF; alternative: SPIDER für qualitative Fragen. | *Beispiel*: **P** ältere Menschen >65; **I** Gleichgewichtstraining; **C** Standard-PT; **O** Sturzrate.

Populationsparameter — Charakteristika der Grundgesamtheit (z. B. MW, SD). Unbekannt; wird durch Stichprobenstatistik geschätzt. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von Stichprobenstatistik (beobachtete Werte). | *Beispiel*: Wahrer MW Schmerzintensität in GG aller LBP-Patient:innen (unbekannt).

Positivismuskritik — Kritik an quantitativen Wissenschaften (E. Husserl): Ignorieren Subjektivität des Forschers und Lebensweltkontext; Reduzieren Komplexität auf Zahlen. | *Abgrenzung*: Führt zur Forderung nach qualitativen Methoden. | *Beispiel*: Reine Zahlenauswertung kann subjektives Erleben von Schmerz nicht erfassen.

p-Wert — Wahrscheinlichkeit, dass beobachteter Effekt zufällig ist, obwohl H_0 wahr ist (Irrtumswahrscheinlichkeit). Klassisch $p < 0,05$ = „signifikant“. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von Konfidenzintervall (gibt Wertebereich). | *Beispiel*: $p = 0,03$ -> 3 % Wahrscheinlichkeit, dass Unterschied Zufall ist.

Q

Qualitative Inhaltsanalyse — Qualitative Auswertungsmethode: systematische, regelgeleitete Analyse von Text-/Kommunikationsmaterial. Kategoriebildung deduktiv oder induktiv. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von GT (eher explorativer). | *Beispiel*: Interviews codieren -> Kategorien bilden -> Häufigkeiten Themen beschreiben.

Querschnittsstudie — Empirische Studie mit **einem** Messzeitpunkt; misst Häufigkeit/Prävalenz. Momentaufnahme. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von Längsschnittstudie (mehrere Zeitpunkte). | *Beispiel PT*: Querschnittserhebung: Wie viele depressive Menschen haben LBP? (einen Tag befragen).

R

Randomisierung — Zufällige Zuteilung von Teilnehmer:innen in Gruppen (Zufallsgenerator, Lostrommel, Umschlag). Minimiert Selektion Bias. | *Abgrenzung*: Unterscheidet sich von bewusster Zuweisung. | *Beispiel*: Computergenerierter Zufallsplan: TN 1–30 -> Intervention, 31–60 -> Kontrolle.

Rationalismus — Erkenntnistheorie: Überlegenheit der Vernunft; logische Beweisführung (Deduktion). Frage nach dem „Warum“ bleibt offen. | *Abgrenzung*: Gegenpol zu Empirismus. | *Beispiel*: Satz des Pythagoras $a^2+b^2=c^2$ durch mathematische Logik bewiesen.

Regel geleitetes Vorgehen (qualitativ)** — Gütekriterium: Forschung folgt festgelegten Reg